宠物急诊就诊流程与电话问诊要点

第一页 出发前：把信息准备齐

急诊处理的效果很大程度取决于主人能否在电话里把关键信息讲清楚，以及到院时是否带着可用的病史资料。

一、打电话之前先确认这六项：

1. 动物基本信息：物种（猫/狗）、品种、性别与是否绝育、估计体重（不知道就报体长与手感，或说「小型犬约 5 公斤」）、年龄或月龄。

2. 主诉与起始时间：什么时候开始、突然发生还是逐渐加重、目前发作频率（例如两小时内呕吐 6 次）。

3. 可能的接触史：换粮、剩菜高脂食物、异物（线绳、玩具、骨头、电池）、人类药物（药片数量与规格）、清洁剂与防冻液、植物（拍照或带枝叶）、鼠药与杀虫剂、蜱虫叮咬。

4. 当前状态三项硬指标：意识（能否认人、有无抽搐昏迷）、呼吸（安静时每分钟次数、有无张口或腹式呼吸）、黏膜（翻开嘴唇看牙龈颜色，按压后回血是否超过两秒）。

5. 是否排尿排便：最后一次排尿时间、尿团大小、有无血尿或腹泻带血。公猫若蹲盆却无尿团，按分钟计的急症处理。

6. 正在使用的药物与既往病史：慢性病（肾病、糖尿病、心脏病、癫痫）、正在服的药物与剂量、既往手术与麻醉反应、疫苗与驱虫记录。

二、电话里要问医生的三件事：

1. 是否需要立刻来、还是可以先在家观察（把上述信息说完再问，不要反过来问「要不要紧」）。

2. 到院前能不能喂食喂水（多数情况下不要，可能需要麻醉或影像检查）。

3. 是否需要同一家医院的特定科室或氧气、输血条件（中毒、大出血、GDV 常需特殊准备）。

第二页 转运途中怎么做

原则是减少刺激、保持呼吸通畅、避免二次伤害，而不是途中尝试治疗。

一、通用搬运：

用航空箱或硬板担架，箱体侧放便于观察；猫尽量Dark安静环境，避免一路抱在怀里颠簸；疼痛或恐惧的动物可能咬人，用毛巾包裹头部区、必要时临时嘴套，但呼吸困难者绝对禁用嘴套。

二、按情况的要点：

车祸或高处坠落：视为脊柱损伤处理，保持头颈躯干一条直线整体平移，不要让它自己走上车；即使外表只是擦伤也要就诊排查内脏出血与膀胱破裂。

呼吸困难：停止一切追赶与检查动作，箱内保持通风、可放置主人衣物减少挣扎，途中避免高温；猫张口呼吸必须持续供氧优先（联系医院说明需要氧气笼）。

抽搐：不要按住、不要往嘴里塞任何东西、不要喂水喂药；移除周围硬物，记录起止时间，发作超过五分钟或连续发作属于最高优先级。

大出血：用干净纱布持续直接压迫五到十分钟，不反复掀开查看；插入体内的异物留在原位固定，不要拔出。

疑似中暑：途中用常温水淋湿全身、保持通风、可用空调冷风，不要冰水浸浴，降温到约 39.4 摄氏度即停止，到院继续评估。

误食毒物：带上原包装或植物样本，记录摄入量与时间；除非兽医电话明确指示，不催吐、不喂牛奶盐水或偏方。

第三页 到院后的配合与随访

一、分诊时主动交付的信息清单：

把电话里说过的内容用一句话概括给接诊医生（时间轴最有用：几点开始、几点加重、几点喂过什么），并出示呕吐物或粪便照片、发作视频、药品包装、疫苗本。

二、检查与治疗的常见顺序：

生命体征稳定优先（供氧、输液、纠正低血糖与电解质）→ 基础检查（血液学、影像、尿检、血压）→ 针对病因的进一步检查（细胞学、培养、超声、专科会诊）。理解这个顺序有助于接受「先稳住再说」的治疗节奏，而不是期待立刻给结论。

三、住院期间的沟通要点：

每天固定时间询问三项：今天的意识与呼吸、进食与排尿、指标变化趋势；需要转院或会诊时问清原因与风险；拒绝或不接受的治疗方案要明确记录在病历上。

四、出院后随访：

带齐药物与书面用药表（药名、剂量、次数、疗程、是否与食物同服）；限制活动按医嘱执行（骨科与腹部手术后的限动是治疗的一部分）；伤口每日观察项目：红肿范围、渗液、异味、缝线完整性；

复查时间与项目要写进日历（常见为 3 天、7 天、14 天拆线、以及影像或血检复查）；
出现下列情况立即联系医院：完全拒食超过二十四小时、持续呕吐、呼吸频率高于安静基线三分之一、无尿、牙龈苍白或发紫、伤口裂开、突发抽搐或瘫痪。

五、把这次急诊变成下次的资料：

留存本次病历与检查报告（拍照备份）、记录疑似诱因与家庭整改项（收纳药物、封窗、换掉含木糖醇食品），并把急诊医院与夜间医院的电话存为常用号码。